



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG

Terakreditasi B (Baik Sekali) **BAN - PT**

Program Studi :

1. Diploma III Kebidanan
2. Sarjana Keperawatan
3. Profesi Ners
4. Sarjana Gizi
5. Sarjana Kebidanan
6. Pendidikan Profesi Bidan

Alamat : Jl. Veteran Mancar Peterongan Jombang Telp./Fax. 0321 - 877025

Jombang, 17 November 2025

Nomor : 364/SHJ/S.Pend/XI/2025

Kepada,-

Lampiran : -

Yth. Direktur RS Prima Husada Sukorejo

Perihal : Pengantar Studi Pendahuluan
Penelitian

Di -
TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir berupa Skripsi bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Husada Jombang Tahun Akademik 2025/ 2026, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : **KIKIS SETYAWATI**

NIM : 2024 03 0264

Prodi : Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang

Tempat Penelitian : Di Ruang Rawat Inap RS Prima Husada Sukorejo

Bersama ini kami mohon agar mahasiswa termaksud mendapatkan ijin dan kesempatan melakukan studi pendahuluan serta diberikan data – data yang berkaitan dengan Penelitian dengan judul “ **PENGARUH PEMBERIAN AROMATHERAPHY LEMON TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN POST OPERASI EXCISI TUMOR MAMAE DI RUANG RAWAT INAP RS PRIMA HUSADA SUKOREJO** ”.

Demikian atas bantuan dan kebijakaannya di sampaikan ucapan terima kasih.

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Husada Jombang



Dr. Hany Puspita Aryani, dr., MM., M.Kes.

NPP: 010801059

PROPOSAL

PENGARUH PEMBERIAN AROMATHERAPY LEMON TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN POST OPERASI EXCISI MAMAE DI RUANG OPERASI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

PENELITIAN *PRA EKSPERIMEN*



Oleh :

KIKIS SETYAWATI
NIM : 2024030264

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
2025**

PROPOSAL

PENGARUH PEMBERIAN AROMATHERAPY LEMON TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN POST OPERASI EXCISI MAMAE DI RUANG OPERASI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)
Pada Program Studi Ilmu Keperawatan
STIKes Husada Jombang



Oleh :

KIKIS SETYAWATI
NIM : 2024030264

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Penelitian Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan Di hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal : November 2025

Oleh

Pembimbing I

Kharisma Dwi Ana, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
NPP. 011305108

Pembimbing II

Fahrur Rozi, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NPP. 010906068

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal ini telah dipresentasikan dan dipertahankan

Di depan tim penguji

Tanggal :

TIM PENGUJI

Tandatangan

Ketua : Yusiana Vidhiastutik, S.Kep.,Ns.,M.Kep. (.....)
NPP : 011305104

Anggota : Kharisma Dwi Ana, S.Kep.,Ns.,M.Kep. (.....)
NPP : 011305108

Anggota : Fahrur Rozi, S.Kep.,Ns.,M.Kep. (.....)
NPP : 010906068

Mengetahui,

Ketua STIKes Husada
Jombang

Ketua Prodi S1 Keperawatan

Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., M.M
NPP. 010201001

Sylvie Puspita, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NPP. 011305103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo”. Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada Prodi Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,Ns.,M.Kep. selaku Direktur RS Prima Husada Sukorejo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
2. Dra. Hj. Soelijah Hadi, M. Kes, MM, Selaku Ketua STIKes Husada Jombang.
3. Sylvie Puspita, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku ketua Prodi Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang.
4. Yusiana Vidhiastutik, S.Kep.,Ns.,M.Kep. selaku ketua penguji atas masukan dan kritikan untuk perbaikan proposal ini.
5. Karisma Dwiana, S.Kep.,Ns.,M.Kep, Selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, arahan selama penyusunan proposal ini.
6. Fahrur Rozi, S.Kep.,Ns.,M.Kep, Selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, masukan, arahan selama penyusunan proposal ini.
7. Kedua Orang Tua yang telah memberi dukungan moril dan material selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang.
9. Teman Teman Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang yang telah memberi dukungan dalam penyusunan proposal ini.
10. Semua pihak yang telah membantu peneliti sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan.

Kami menyadari proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amiin.

Jombang,
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SIMBOL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Dasar Aromatherapy Lemon.....	6
2.2 Konsep Dasar Nyeri	8
2.3 Konsep Dasar Exsisi Mamae	17
2.4 Keaslian Penelitian.....	20
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS	
3.1 Kerangka Konsep.....	22
3.2 Hipotesis	23
BAB VI METODE PENELITIAN	
4.1 Desain Penelitian	24
4.2 Kerangka Kerja	25
4.3 Variabel Penelitian	26
4.4 Definisi Operasional	26
4.5 Waktu dan Tempat.....	27
4.6 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	27
4.7 Teknik Pengumpulan Data	29
4.8 Analisa Data.....	30
4.9 Etika Penelitian	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
4.1 Definisi operasional.....	26
4.2 Interpretasi korelasi.....	30

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konsep.....	22
4.1 Kerangka Kerja.....	25

DAFTAR SIMBOL

%	: Persen
>	: lebih dari
<	: Kurang dari
α	: Alpha
ρ	: Rho
N	: Nilai yang di dapat
π	: Phi
β	: Beta
&	: dan

DAFTAR SINGKATAN

KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
RS	: Rumah Sakit
WHO	: <i>World Health Organization</i>
Dkk	: Dan Kawan-kawan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Jatim	: Jawa Timur
Kemenkes	: Kementrian Kesehatan
RI	: Republik Indonesia
NRS	: <i>Numeric Rating Scale</i>)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Permohonan menjadi responden
- Lampiran 2 : Pernyataan persetujuan (*Informed Consent*)
- Lampiran 3 : Kuesioner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nyeri menjadi masalah utama yang sering dialami pasien pasca operasi, termasuk setelah tindakan eksisi mammae, karena dapat menghambat proses penyembuhan, menurunkan kemampuan mobilisasi, mengganggu kualitas tidur, serta memengaruhi kondisi psikologis. Penggunaan obat analgesik secara farmakologis memang efektif, namun berisiko menimbulkan efek samping, sehingga diperlukan alternatif terapi komplementer yang lebih aman. Salah satu pendekatan yang potensial adalah aromaterapi lemon, yang memiliki efek relaksasi dan analgesik melalui stimulasi sistem limbik untuk menurunkan persepsi nyeri (Putri, 2022). Kandungan aktif seperti limonene dan linalool dalam minyak esensial lemon terbukti dapat menurunkan respons stres dan memengaruhi neurotransmitter yang berperan dalam pengendalian nyeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien pasca operasi yang mendapatkan aromaterapi lemon mengalami penurunan intensitas nyeri yang lebih signifikan dibandingkan kelompok tanpa aromaterapi (Rahman, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aromaterapi lemon dapat menjadi intervensi non-farmakologis yang sederhana, aman, dan efektif untuk membantu mengurangi nyeri serta meningkatkan kenyamanan pasien setelah operasi eksisi mammae.

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2021), lebih dari 80% pasien pasca operasi di dunia mengalami nyeri sedang hingga berat, yang jika tidak ditangani dapat menghambat proses pemulihan. Sedangkan di Indonesia

Kementerian Kesehatan (2022), melaporkan bahwa sekitar 70% pasien pasca operasi masih mengeluhkan nyeri, terutama pada kasus bedah mayor seperti eksisi mammae. Sementara itu, di Jawa Timur, data Dinas Kesehatan (2023) menunjukkan bahwa keluhan nyeri pasca operasi masih cukup tinggi dengan prevalensi mencapai 65%, di mana sebagian besar pasien menyatakan manajemen nyeri yang diberikan belum sepenuhnya efektif. Hal ini menegaskan perlunya penerapan terapi komplementer, salah satunya aromaterapi lemon, untuk membantu menurunkan intensitas nyeri pasca operasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan September 2025 dari data Rekam Medik RS Prima Husada Sukorejo pasien yang menjalani operasi mammae terhitung sejak bulan Januari sampai Agustus 2025 rata-rata 30 pasien per bulan

Operasi eksisi mammae adalah tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat massa atau tumor pada payudara, baik jinak maupun ganas, dengan tujuan diagnosis maupun terapi. Salah satu gejala yang dirasakan oleh pasien post op eksisi mammae adalah nyeri. Penyebab utama tingginya intensitas nyeri pada pasien pasca operasi, termasuk eksisi mammae, dipengaruhi oleh faktor trauma jaringan akibat tindakan pembedahan, respon inflamasi, serta faktor psikologis seperti kecemasan dan stres. Selain itu, manajemen nyeri yang masih berfokus pada penggunaan obat-obatan farmakologis sering kali kurang optimal karena dosis terbatas, keterlambatan pemberian, serta adanya efek samping obat (Siregar, 2022). Rendahnya pemanfaatan terapi non-farmakologis juga turut memperburuk kondisi nyeri pasien. Dampak dari nyeri yang tidak tertangani dengan baik cukup serius,

antara lain terganggunya mobilisasi dini, menurunnya kualitas tidur, meningkatnya risiko komplikasi, serta memperlambat proses penyembuhan luka. Nyeri yang berkelanjutan juga dapat menurunkan kualitas hidup pasien dan memengaruhi kondisi psikologis seperti timbulnya rasa takut dan depresi (Lestari, 2023). Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan pasien secara fisik dan mental, tetapi juga dapat menambah beban biaya perawatan rumah sakit akibat perpanjangan masa rawat inap.

Salah satu upaya solusi untuk menurunkan intensitas nyeri pada pasien pasca operasi eksisi mammae adalah melalui pemberian aromaterapi lemon. Aromaterapi lemon mengandung senyawa aktif seperti limonene dan linalool yang bekerja menstimulasi sistem limbik pada otak sehingga mampu memberikan efek relaksasi, menurunkan stres, dan mengurangi persepsi nyeri (Putri, 2022). Terapi ini bersifat non-invasif, mudah diaplikasikan, serta memiliki risiko efek samping yang minimal dibandingkan dengan terapi farmakologis. Dengan demikian, penggunaan aromaterapi lemon dapat menjadi intervensi komplementer yang efektif, aman, dan mendukung kenyamanan pasien dalam proses pemulihan pasca operasi.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae sebelum diberikan aromaterapi lemon di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo.
2. Mengidentifikasi penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae sesudah diberikan aromaterapi lemon di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo.
3. Menganalisis pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam bidang manajemen nyeri nonfarmakologis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dasar teori bahwa stimulasi aroma sitrus, seperti lemon, dapat merangsang sistem limbik dan menurunkan persepsi nyeri melalui efek relaksasi dan peningkatan mood, sehingga dapat dijadikan acuan dalam intervensi keperawatan untuk mengurangi nyeri pasca operasi secara holistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi RS Prima Husada Sukorejo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan terapi komplementer nonfarmakologis dalam manajemen nyeri. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan yang holistik, efisien, dan aman, serta mendukung kebijakan inovatif dalam pengelolaan nyeri tanpa ketergantungan pada obat-obatan analgesik.

2. Bagi STIKes Husada Jombang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan keperawatan, khususnya dalam bidang keperawatan medikal bedah dan terapi komplementer. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran, penelitian lanjutan, serta pengabdian masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan intervensi keperawatan berbasis bukti (*evidence-based nursing*).

3. Bagi perawat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah dalam penerapan terapi komplementer sebagai bagian dari asuhan keperawatan holistik. Penelitian ini dapat membantu perawat memahami mekanisme kerja aromaterapi lemon dalam menurunkan nyeri, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif nonfarmakologis yang efektif, aman, dan mudah diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan serta mempercepat proses pemulihan pasien.

4. Bagi responden

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi responden karena dapat membantu mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan setelah menjalani operasi eksisi mammae melalui pemberian aromaterapi lemon. Dengan adanya terapi komplementer ini, pasien memperoleh pengalaman baru dalam manajemen nyeri non-farmakologis yang aman, mudah, dan minim efek samping. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, mempercepat pemulihan, serta menurunkan kecemasan yang sering muncul pasca operasi

5. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan serta pengalaman dalam mengkaji efektivitas terapi komplementer, khususnya aromaterapi lemon, terhadap penurunan nyeri pasca operasi. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya di bidang keperawatan medikal bedah, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan intervensi non-farmakologis yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Arometherapy Lemon

2.1.1 Pengertian

Aromaterapi lemon merupakan salah satu bentuk terapi komplementer yang memanfaatkan minyak esensial dari kulit buah lemon (*Citrus limon*) untuk memberikan efek relaksasi, menurunkan stres, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Menurut Babbar (2021), minyak esensial lemon mengandung komponen bioaktif utama seperti limonene, β -pinene, dan citral yang berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki efek terapeutik. Aromaterapi lemon biasanya digunakan melalui inhalasi, difusi udara, atau aplikasi topikal dengan pelarut tertentu (Nguyen, 2024).

2.1.2 Kandungan dan Sifat Farmakologis Lemon

Minyak esensial lemon kaya akan senyawa fitokimia yang memberikan berbagai manfaat kesehatan. Kandungan utamanya adalah:

- 1) Limonene: bersifat antioksidan dan antiinflamasi (Attia, 2023).
- 2) Citral: memberikan aroma segar serta berfungsi sebagai antibakteri (Rasquin, 2022).
- 3) β -pinene dan γ -terpinene: berperan dalam efek antimikroba dan peningkatan suasana hati (Hennegan, 2021).

Senyawa-senyawa tersebut menjadikan aromaterapi lemon efektif dalam meningkatkan imunitas, menurunkan tingkat kecemasan, serta mendukung kualitas tidur (Anthon, 2024).

2.1.3 Mekanisme Kerja Aromaterapi Lemon

Aromaterapi bekerja dengan cara menstimulasi sistem olfaktori (indera penciuman) yang terhubung langsung dengan sistem limbik otak, pusat pengatur emosi dan hormon. Menurut Thiyagarajan (2022), inhalasi aroma lemon dapat meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang berhubungan dengan perasaan tenang dan bahagia. Selain itu, senyawa aktif dalam lemon juga dapat diserap melalui kulit dan memberikan efek fisiologis lokal.

2.1.4 Manfaat Aromaterapi Lemon

Aromaterapi lemon telah banyak digunakan dalam bidang kesehatan sebagai terapi tambahan. Manfaat yang paling sering dilaporkan antara lain:

- 1) Mengurangi stres dan kecemasan – Inhalasi lemon terbukti menurunkan kadar kortisol dan memberikan efek relaksasi (Nagy, 2023).
- 2) Meningkatkan konsentrasi dan suasana hati – Aroma lemon dapat meningkatkan kewaspadaan dan memperbaiki mood (Pargar, 2025).
- 3) Mendukung kesehatan pernapasan – Senyawa antibakteri dalam lemon membantu mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan (Yanti, 2023).
- 4) Meningkatkan sistem kekebalan tubuh – Kandungan antioksidan berperan dalam melawan radikal bebas (Babbar, 2021).
- 5) Membantu mengurangi mual – Terutama pada ibu hamil trimester pertama (Nguyen, 2024).

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Aromaterapi Lemon

Efektivitas penggunaan aromaterapi lemon dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Metode penggunaan: inhalasi biasanya lebih cepat memberikan efek dibanding topikal (Attia, 2023).
- 2) Konsentrasi minyak esensial: dosis yang tepat penting untuk menghindari iritasi (Rasquin, 2022).
- 3) Kondisi individu: respons tubuh berbeda tergantung usia, kesehatan, dan sensitivitas (Hennegan, 2021).
- 4) Lingkungan penggunaan: tempat yang nyaman mendukung tercapainya efek relaksasi (Anthon, 2024).

2.1.6 Aromaterapi Lemon dalam Kesehatan Modern

Aromaterapi lemon semakin banyak diteliti sebagai bagian dari terapi komplementer. WHO (2022) menekankan bahwa pemanfaatan aromaterapi harus berbasis bukti ilmiah serta digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti, pengobatan medis. Dengan kandungan bioaktifnya, aromaterapi lemon berpotensi besar dalam mendukung kesehatan mental dan fisik, terutama pada remaja dan dewasa yang rentan stres (Pargar, 2025).

2.2 Konsep Dasar Nyeri

2.2.1 Definisi

Nyeri adalah kondisi yang menyebabkan suatu ketidaknyamanan. Rasa ketidaknyamanan dapat disebabkan oleh terjadinya kerusakan saraf sensori atau juga diawali rangsangan aktivitas sel T ke korteks serebri dan menimbulkan persepsi nyeri (Bahrudin, 2018). Nyeri adalah pengalaman

sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual ataupun potensial. Nyeri merupakan alasan utama seseorang untuk mencari bantuan perawatan kesehatan dan yang paling banyak dikeluhkan (Kusumaningrum, 2017). Nyeri adalah sensasi yang sangat tidak menyenangkan dan sangat individual yang tidak dapat dibagi dengan orang lain. Nyeri bersifat universal, berbeda persepsi dan bersifat individual. Nyeri merupakan mekanisme fisiologis bertujuan untuk melindungi diri dan disebabkan oleh stimulus tertentu (Bahrudin, 2018).

2.2.2 Karakteristik Nyeri

Menurut Tjahya (2017), karakteristik nyeri dibagi dalam beberapa metode P, Q, R, S, T, yaitu:

- 1) Faktor Pencetus (P: *Provocate*), perawat mengkaji tentang penyebab atau stimulasi nyeri pada pasien. Perawat melakukan observasi dibagian tubuh yang mengalami cedera. Apabila perawat mencurigai adanya nyeri psikogenik maka perawat dapat mengeksplorasi perasaan pasien dengan menanyakan perasaan apa yang dapat mencetus nyeri.
- 2) Kualitas (Q: *Quality*), kualitas nyeri adalah hal yang subjektif yang diungkapkan pasien, pasien sering mendeskripsikan nyeri dengan kalimat: berdenyut, tajam, tumpul, berpindah-pindah, perih, seperti tertindih, tertusuk. Tiap-tiap pasien berbeda dalam melaporkan kualitas nyeri yang dirasakan.
- 3) Lokasi (R: *Region*), mengkaji lokasi nyeri maka perawat meminta pada pasien untuk menunjukkan semua bagian/daerah yang dirasakan nyeri oleh pasien. Untuk melokalisasi nyeri lebih spesifik, maka perawat dapat meminta

pasien untuk melacak daerah nyeri dari titik yang paling nyeri, apabila nyeri bersifat difus (menyebar) maka kemungkinan akan sulit untuk dilacak.

- 4) Keparahan (S: *Severe*), tingkat keparahan pasien tentang nyeri merupakan karakteristik yang paling subjektif. Pada pengkajian ini pasien disuruh menggambarkan nyeri yang dirasakannya sebagai nyeri ringan, sedang, berat. Kesulitannya adalah makna dari setiap istilah berbeda bagi perawat dan pasien, tidak ada batasan khusus yang membedakan antara nyeri ringan, sedang, berat. Ini juga disebabkan karena pengalaman nyeri setiap orang berbeda-beda.
- 5) Durasi (T: *Time*), perawat menanyakan pada pasien untuk menentukan durasi, awitan, dan rangkaian nyeri, misalnya menanyakan “kapan nyeri mulai dirasakan?”, “sudah berapa lama nyeri dirasakan?”, “apakah nyeri yang dirasakan terjadi pada waktu yang sama setiap hari?”, “seberapa sering nyeri kambuh?”.

2.2.3 Skala Nyeri

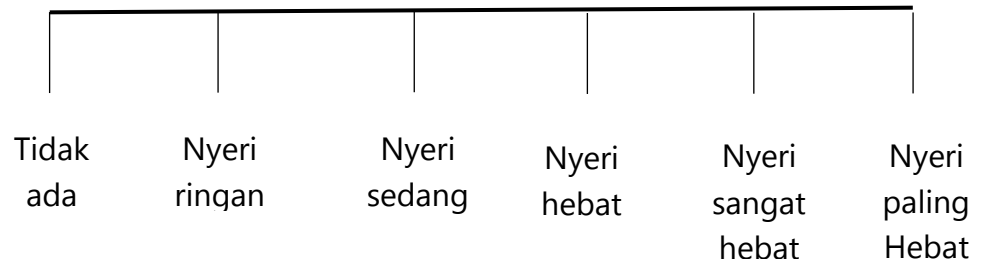
Menurut Tjahya (2017), ada beberapa skala pengukuran nyeri yaitu sebagai berikut:

- 1) Skala Intensitas Nyeri Numerik/NRS(*Numeric Rating Scale*)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak Nyeri	Nyeri Ringan			Nyeri Sedang			Nyeri Hebat			

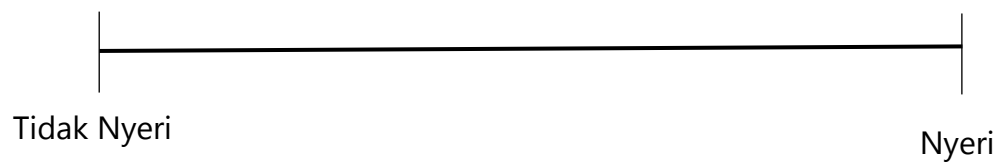
Gambar 2.1 Skala Numerik

2) Skala Deskriptif



Gambar 2.2 Skala Deskriptif

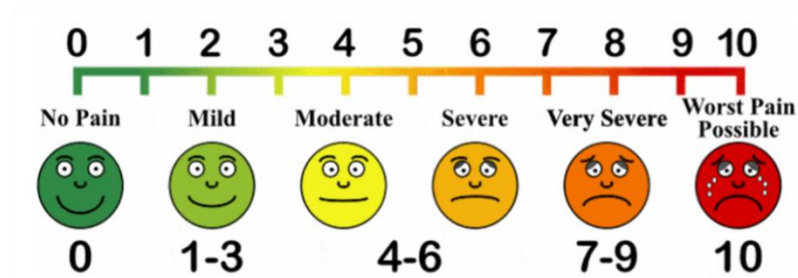
3) Skala Analog Visual



Gambar 2.3 Skala Nyeri Analog Visual

(Potter & Perry, 2017)

4) Skala Nyeri Muka



Gambar 2.4 Skala Nyeri Muka

(Judha dkk., 2018)

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri

Faktor yang mempengaruhi nyeri diantaranya persepsi nyeri, usia, jenis kelamin, faktor sosiobudaya, pengalaman masa lalu (Potter & Perry, 2017)

1) Persepsi nyeri

Persepsi nyeri merupakan persepsi individu menerima dan menginterpretasikan nyeri berdasarkan pengalaman masing-masing. Nyeri yang dirasakan tiap individu berbeda-beda. Persepsi nyeri dipengaruhi oleh toleransi individu terhadap nyeri.

2) Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya merupakan faktor penting dalam respons individu terhadap nyeri. Respon terhadap nyeri cenderung merefleksikan moral dan budaya masing-masing.

3) Usia

Usia dapat mengubah persepsi dan pengalaman nyeri. Individu yang berumur lebih tua mempunyai metabolisme yang lebih lambat dan rasio lemak tubuh terhadap masa otot lebih besar dibanding individu berusia lebih muda, sehingga analgesik dosis kecil mungkin cukup untuk menghilangkan nyeri.

4) Jenis kelamin

Jenis kelamin dapat menjadikan faktor yang dapat mempengaruhi respon nyeri. Pada dasarnya pria lebih jarang melaporkan nyeri dibandingkan wanita.

5) Pengalaman masa lalu

Pengalaman sebelumnya mengenai nyeri mempengaruhi persepsi akan nyeri yang dialami saat ini. Individu yang memiliki pengalaman negatif dengan nyeri pada masa kanak-kanak dapat memiliki kesulitan untuk mengelola nyeri.

6) Ansietas (kecemasan)

Hubungan antara nyeri dengan kecemasan bersifat kompleks. Kecemasan terkadang meningkatkan persepsi terhadap nyeri, tetapi nyeri juga menyebabkan perasaan cemas. Dalam teorinya melaporkan bahwa stimulus nyeri yang mengaktifasi bagian dari sistem limbic dipercaya dapat mengontrol emosi, terutama kecemasan. Sistem limbik memproses reaksi emosional terhadap nyeri, apakah dirasa mengganggu atau berusaha untuk mengurangi nyeri.

7) Suku bangsa

Nilai-nilai dan kepercayaan terhadap budaya mempengaruhi bagaimana seseorang individu mengatasi rasa sakitnya. Individu belajar tentang apa yang diharapkan dan diterima oleh budayanya, termasuk bagaimana reaksi terhadap nyeri. Beberapa budaya percaya bahwa menunjukkan rasa sakit adalah suatu hal yang wajar. Sementara budaya yang lain lebih cenderung untuk tertutup. Ada perbedaan makna dan perilaku yang berhubungan dengan nyeri antara beragam kelompok budaya. Suatu pemahaman yang baik tentang makna nyeri berdasarkan budaya seseorang akan membantu perawat dalam membuat rencana asuhan keperawatan yang lebih relevan untuk nyeri yang dialami.

8) Perhatian

Tingkat perhatian seseorang terhadap nyeri akan mempengaruhi persepsi nyeri yang dirasakan, sedangkan upaya pengalihan (distraksi) dihubungkan dengan respon nyeri. Konsep inilah yang mendasari berbagai terapi untuk menghilangkan nyeri, seperti relaksasi, teknik imajinasi terbimbing (*guided imagery*), dan masase. Dengan memfokuskan perhatian dan konsentrasi klien terhadap stimulus lain, kesadaran mereka akan adanya nyeri menjadi menurun.

9) Kelemahan (*fatigue*)

Kelemahan akan meningkatkan persepsi seseorang terhadap nyeri dan dapat menurunkan kemampuan untuk mengatasi suatu masalah. Apabila kelemahan terjadi disepanjang waktu istirahat, persepsi terhadap nyeri akan lebih besar.

10) Teknik koping

Teknik koping mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatasi nyeri. Seseorang yang memiliki koping yang baik mereka dapat mengontrol rasa nyeri yang dirasakan. Tetapi sebaliknya, jika seseorang yang memiliki koping yang buruk mereka akan merasa bahwa orang lainlah yang akan bertanggung jawab terhadap nyeri yang dialaminya. Konsep inilah yang dapat diaplikasikan dalam penggunaan analgesik yang dikontrol pasien (*patient-controlled analgesia / PCA*).

11) Keluarga dan dukungan sosial

Seseorang yang merasakan nyeri terkadang bergantung kepada anggota keluarga yang lain atau teman dekat untuk memberikan dukungan, bantuan,

atau perlindungan. Walaupun rasa nyeri masih terasa, tetapi kehadiran keluarga ataupun teman terkadang dapat membuat pengalaman nyeri yang menyebabkan stress sedikit berkurang. Kehadiran orang tua sangat penting bagi anak-anak yang mengalami nyeri.

2.2.5 Respon terhadap nyeri

Menurut Potter & Perry (2017), ada dua respons terhadap nyeri, yaitu respons fisiologis dan respons perilaku. Kedua respons ini timbul ketika seseorang terpapar dengan nyeri, dan masing – masing individu mempunyai karakteristik yang berbeda dalam merespons nyeri tersebut.

1) Respons fisiologis terhadap nyeri

Respons nyeri fisiologis terhadap nyeri dapat sangat membahayakan individu. Pada saat impuls nyeri naik ke medula spinalis menuju batang otak dan talamus, sistem saraf otonom menjadi tersimulasi sebagai bagian dari respons stress. Nyeri dengan intensitas ringan hingga sedang dan nyeri yang superfisial menimbulkan reaksi “flight-atau-fight”, yang merupakan sindrom adaptasi umum. Stimulus pada cabang simpatis pada saraf otonom menghasilkan respons fisiologis. Apabila nyeri berlangsung terus – menerus, berat, atau dalam, dan secara tipikal melibatkan organ–organ visceral (seperti nyeri pada infark miokard, kolik akibat kandung empedu atau batu ginjal), sistem saraf parasimpatis menghasilkan suatu aksi. Kecuali pada kasus–kasus nyeri traumatik yang berat, yang menyebabkan individu mengalami syok, kebanyakan individu mencapai tingkat adaptasi, yaitu ketika tanda– tanda fisik kembali normal. Dengan demikian, seseorang yang mengalami nyeri tidak akan selalu memperlihatkan tanda–tanda fisik.

2) Respons perilaku

Apabila nyeri dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, hal tersebut dapat mengancam kesejahteraan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa pasien memilih untuk tidak mengekspresikan nyeri yang dirasakan, karena mereka menganggap bahwa ekspresi tersebut akan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merupakan salah satu tanda bahwa mereka kehilangan kontrol terhadap diri mereka sendiri. Pasien yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap nyeri mampu menahan rasa nyeri tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Sedangkan, seseorang yang memiliki toleransi nyeri yang rendah dapat mencari upaya untuk menghilangkan rasa nyeri sebelum nyeri terjadi. Gerakan tubuh dan ekspresi wajah dapat mengindikasikan adanya nyeri, seperti mengatubkan gigi-gigi, memegang tubuh yang terasa sakit, postur tubuh yang membungkuk, dan ekspresi wajah yang meringis. Beberapa klien bahkan menangis atau mengerang kesakitan dan biasanya terlihat gelisah atau meminta sesuatu secara terus-menerus kepada perawat.

2.2.6 Indikator Nyeri

Menurut Nursalam (2020), indikator penilaian nyeri berdasarkan tingkat nyeri yaitu :

- 1) Tidak nyeri dengan skor 0
- 2) Nyeri ringan
 - a. Nyeri sangat ringan dengan skor 1
 - b. Nyeri tidak nyaman dengan skor 2
 - c. Nyeri dapat ditoleransi dengan skor 3

3) Nyeri sedang

- a. Nyeri menyusahkan dengan skor 4
- b. Nyeri sangat menyusahkan dengan skor 5
- c. Nyeri hebat dengan skor 6

4) Nyeri berat

- a. Nyeri sangat hebat dengan skor 7
- b. Nyeri sangat menyiksa dengan skor 8
- c. Nyeri tak tertahankan dengan skor 9
- d. Nyeri tak dapat diungkapkan dengan skor 10

2.3 Konsep Dasar Eksisi Mamae

2.3.1 Pengertian Eksisi Mamae

Eksisi mamae adalah tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat massa atau tumor pada payudara, baik jinak maupun ganas, dengan tujuan diagnosis maupun terapi. Tindakan ini dapat berupa eksisi lokal (lumpektomi), wide excision, atau bagian dari prosedur mastektomi tergantung indikasi klinis (Nagy, 2023). Menurut Thiyagarajan (2022), eksisi mamae sering dilakukan sebagai terapi konservatif kanker payudara atau pengangkatan fibroadenoma yang bersifat jinak.

2.3.2 Tujuan dan Indikasi Eksisi Mamae

Tujuan utama eksisi mamae adalah mengangkat massa abnormal pada payudara sekaligus mempertahankan jaringan sehat sebanyak mungkin. Indikasi tindakan ini meliputi:

- 1) Tumor jinak seperti fibroadenoma dan kista (Rasquin, 2022).
- 2) Lesi premaligna yang berpotensi berkembang menjadi kanker (Attia, 2023).
- 3) Kanker payudara stadium awal sebagai bagian dari *breast-conserving surgery* (Nguyen, 2024).
- 4) Diagnosis histopatologis untuk memastikan jenis dan karakteristik tumor (Pargar, 2025).

2.3.3 Kondisi Post Operasi Eksisi Mamae

Pasien pasca operasi eksisi mamae umumnya mengalami berbagai kondisi fisiologis dan psikologis. Secara fisik, pasien dapat mengalami nyeri di area pembedahan, pembengkakan, hematoma, hingga keterbatasan gerakan lengan pada sisi yang dioperasi (Hennegan, 2021). Dari sisi psikologis, pasien mungkin menghadapi kecemasan, stres, atau penurunan citra tubuh akibat tindakan operasi (Yanti, 2023). Oleh karena itu, perawatan pasca operasi sangat penting untuk memulihkan kondisi pasien secara menyeluruh.

2.3.4 Prinsip Perawatan Post Operasi Eksisi Mamae

Perawatan pasca operasi eksisi mamae bertujuan mencegah komplikasi dan mendukung pemulihan. Prinsip-prinsip perawatan meliputi:

- 1) Manajemen Nyeri – pemberian analgesik sesuai kebutuhan dan teknik non-farmakologis seperti relaksasi (Anthon, 2024).
- 2) Perawatan Luka – menjaga kebersihan luka operasi, mencegah infeksi, dan mengganti balutan sesuai prosedur (Babbar, 2021).
- 3) Mobilisasi Dini – latihan gerakan lengan secara bertahap untuk mencegah kekakuan sendi (Nguyen, 2024).

- 4) Pemantauan Komplikasi – seperti perdarahan, infeksi, limfedema, atau seroma (Attia, 2023).
- 5) Dukungan Psikologis – memberikan edukasi, konseling, dan dukungan emosional kepada pasien (Yanti, 2023).

2.3.5 Komplikasi Post Operasi Eksisi Mamae

Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi antara lain:

- 1) Infeksi luka operasi akibat kebersihan yang kurang optimal (Rasquin, 2022).
- 2) Hematoma dan seroma di area pembedahan (Nagy, 2023).
- 3) Limfedema pada lengan yang dioperasi jika ada pengangkatan kelenjar getah bening (Pargar, 2025).
- 4) Gangguan psikologis seperti depresi atau gangguan citra tubuh (Anthon, 2024).

2.3.6 Rehabilitasi dan Edukasi Pasien

Pasien post eksisi mamae membutuhkan program rehabilitasi yang terintegrasi, termasuk latihan fisik, terapi psikologis, dan konseling kesehatan reproduksi. WHO (2022) menekankan pentingnya dukungan multidisiplin untuk pasien kanker payudara, mulai dari dokter, perawat, psikolog, hingga keluarga. Edukasi mengenai perawatan luka, nutrisi, dan kontrol rutin menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Nguyen, 2024).

2.4 Keaslian Penelitian

No.	Judul, Penulis, Tahun	Metode (desain, sampel, variabel, instrumen, analisis)	Hasil penelitian
1	Pengaruh Aromaterapi Lemon terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Laparotomi. El Rahmayati, Hardiansyah & Nurhayati (2022).	Desain: Quasi-eksperiment satu kelompok pretest-posttest. Sampel: 32 responden post operasi laparotomi (accidental sampling). Variabel: intensitas nyeri (dep.), intervensi aromaterapi lemon. Instrumen: Numeric Rating Scale (NRS). Analisis: Uji Wilcoxon.	Univariat: rata-rata nyeri sebelum intervensi berada di tingkat nyeri sedang; demografi responden, jenis operasi laparotomi. Terdapat penurunan signifikan intensitas nyeri setelah diberikan aromaterapi lemon ($p = 0,000$).
2	Pengaruh Aromaterapi Lemon terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Operasi di Ruang Rawat Bedah. Rahma Fitri Zulaina (2024).	Desain: Pretest-posttest satu kelompok (pre-experimental). Sampel: 18 orang pasien post operasi di ruang bedah (Hospital Haji Abdoel Madjid Batoe). Variabel: nyeri (dep.), intervensi aromaterapi lemon. Instrumen: Numeric Rating Scale (NRS). Analisis: Paired t-test.	Univariat: rata-rata nyeri pretest ≈ 5.11 (moderate); demografi, jenis operasi. Nyeri rata-rata turun signifikan sesudah intervensi aromaterapi lemon, $p < 0,001$.
3	The effect of lemon inhalation aromatherapy on pain, nausea, as well as vomiting lower extremity fracture surgery: a randomized trial. Rambod, Pasyar, Karimian et al. (2023).	Desain: Randomized clinical trial. Sampel: 90 pasien operasi fraktur ekstremitas bawah. Variabel: nyeri, mual, muntah, penilaian neurovaskular; intervensi lemon inhalasi vs kontrol. Instrumen: NRS, Rhodes Index of Nausea, Vomiting, and Retching; neurovascular	Univariat: demografi, skor nyeri & mual/muntah pra-intervensi, pembagian kelompok kontrol dan intervensi. Terdapat perbedaan signifikan antara kelompok intervensi dan kontrol dalam pengurangan nyeri; aromaterapi lemon menurunkan intensitas nyeri secara bermakna ($p < 0.001$).

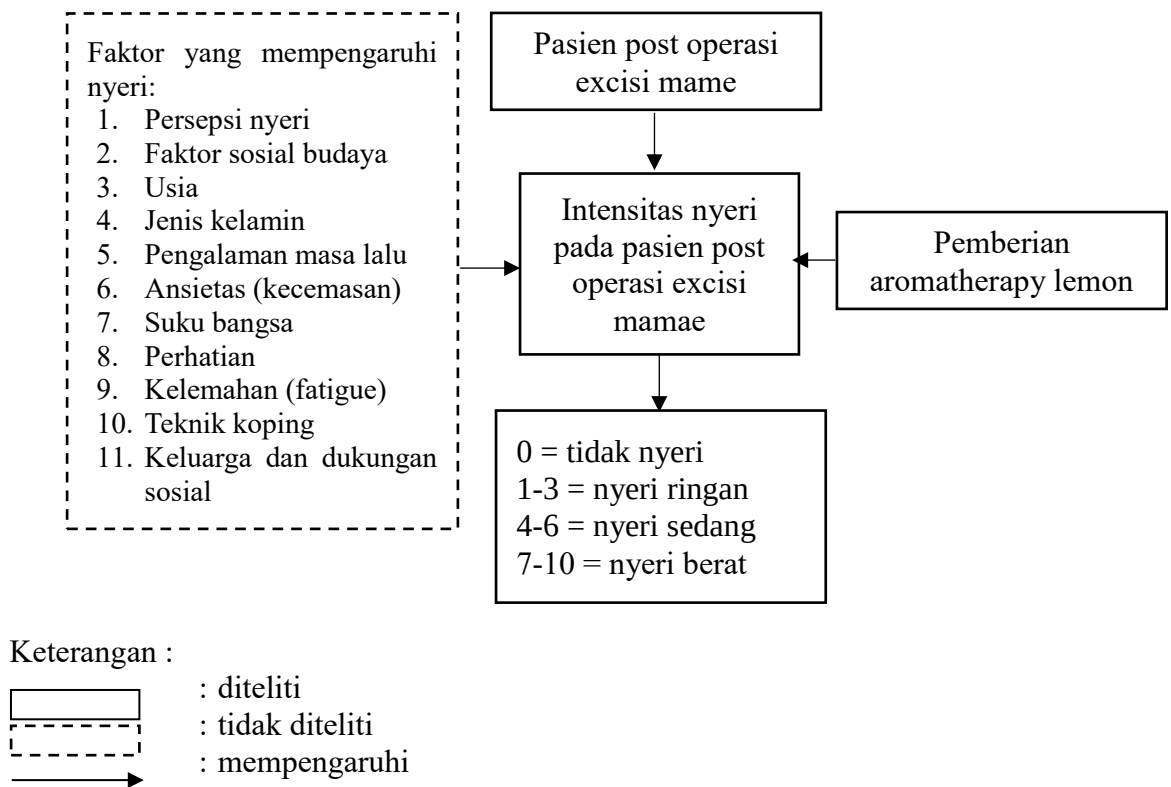
		observation charts. Analysis: Wilcoxon, ANCOVA, repeated measure ANCOVA.	
--	--	--	--

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah tahap paling penting dalam suatu penelitian, konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat di komunikasikan dan dapat membentuk suatu teori yang menjelaskan suatu keterkaitan variabel (Nursalam, 2020).



Gambar 3.1 : Kerangka konseptual pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo

3.2 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (Nursalam, 2020). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₁: Ada pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo

BAB VI

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Pra Eksperimental* karena membutuhkan pembuktian dan pengembangan ilmu keperawatan yang ada di lapangan melalui suatu intervensi keperawatan dan observasi dari intervensi yang diberikan (Nursalam, 2020). Rancangan penelitian merupakan sesuatu strategi penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan data (Nursalam, 2020). Penelitian ini menggunakan *one group pre test – post test design*, yaitu mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok perlakuan dan satu kelompok kontrol. Kelompok perlakuan diobservasi sebelum dilakukan intervensi, dan kemudian diobservasi lagi setelah dilakukan intervensi (Nursalam, 2020).

Tabel 4.1 Rancangan *one group pra-pascates deasign*

Subjek	Pra	Perlakuan	Post
K	O	I	O1

Keterangan :

K : Subjek

O : Observasi nyeri sebelum diberikan aromatherapy lemon

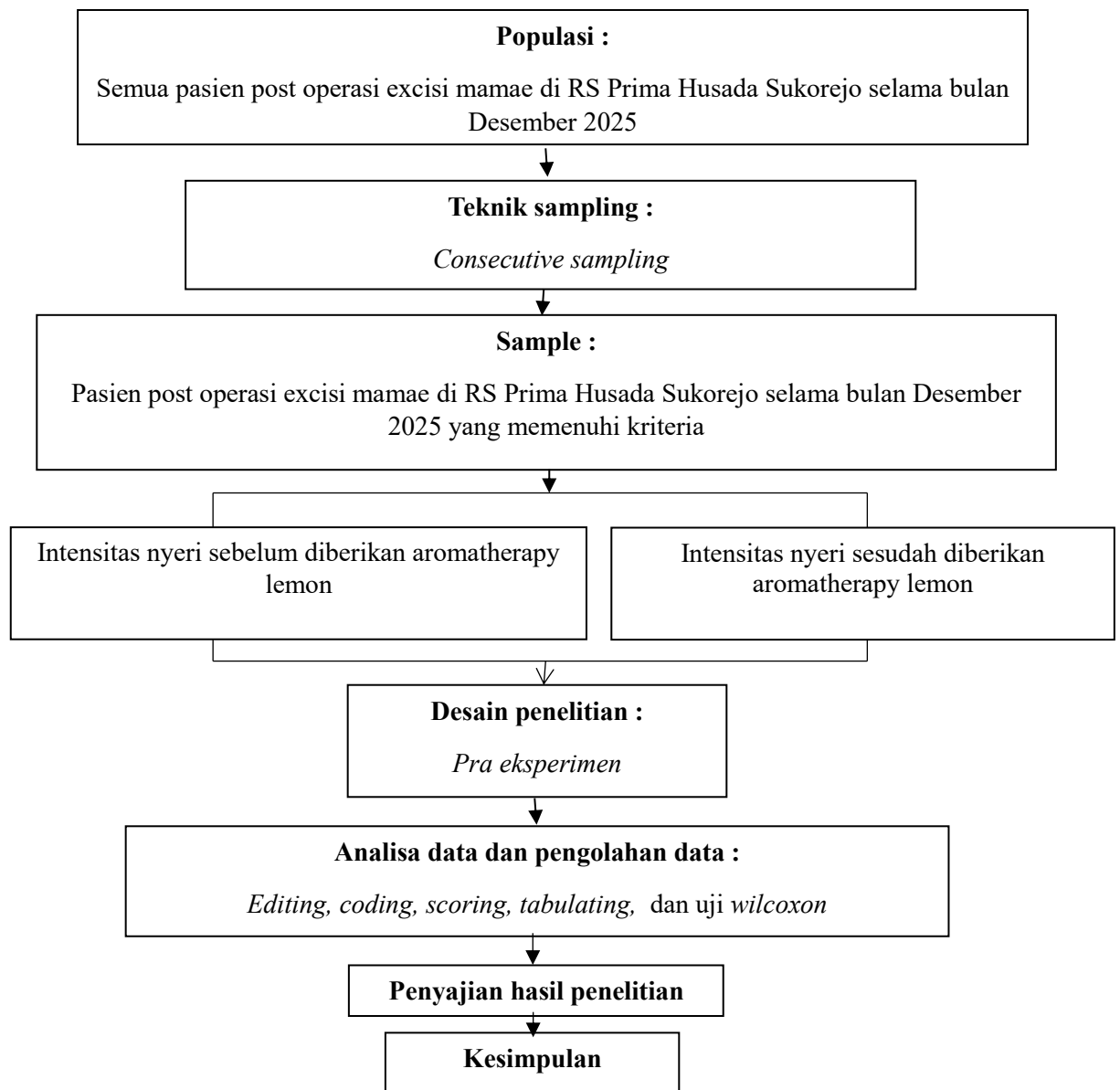
I : Intervensi aromatherapy lemon

O1 : Observasi nyeri sesudah diberikan aromatherapy lemon

4.2 Kerangka Kerja Penelitian (frame work)

Kerangka kerja adalah bagian kerja terhadap rancangan kegiatan penelitian yang akan di lakukan meliputi siapa yang akan diteliti (subyek penelitian), variabel yang akan diteliti dan variabel yang akan mempengaruhi dalam penelitian (Nursalam, 2020).

Adapun kerangka kerja sebagai berikut:



Gambar 4.1 : Kerangka kerja pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi RS Prima Husada Sukorejo

4.3 Variabel Penelitian

4.3.1 Variabel independen (bebas)

Variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. (Nursalam, 2020). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian aromatherapy lemon

4.3.2 Variabel dependen (terikat)

Variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan oleh variabel lain. Dengan kata lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah intensitas nyeri post operasi excisi mammae

4.4 Definisi Operasional

Merupakan variabel operasional yang dilakukan penelitian berdasarkan karakteristik yang diamati. Ditentukan berdasarkan pada parameter ukuran dalam penelitian serta mengungkapkan variabel dari skala pengukuran masing masing variabel (Nursalam, 2020).

Tabel 4.1 : Definisi operasional Pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi Rs Prima Husada Sukorejo

Variabel	Definisi operasional	Parameter	Alat ukur	Skala	Skor
Variabel independen: pemberian aromatherapy lemon	Proses pemberian minyak esensial dengan aroma lemon (Citrus limon) melalui metode inhalasi yang dilakukan pada pasien post	1. Lama pemberian (menit) 2. Jumlah tetes aromaterap 3. Metode pemberian (inhalasi/dif fuser)	SOP	-	-

	operasi <i>excisi</i> <i>mamae</i> untuk memberikan efek relaksasi dan membantu menurunkan intensitas nyeri. Aromaterapi diberikan dengan cara meneteskan 2–3 tetes minyak esensial lemon pada kapas atau diffuser, kemudian dihirup pasien selama 10–15 menit.	4. Frekuensi pemberian			
Variabel dependen: Intensitas nyeri pasien post operasi <i>excisi mamae</i>	Kondisi ketidaknyamanan yang terjadi akibat nyeri post operasi <i>excisi mamae</i>	Nyeri : 1. Tidak nyeri 2. Nyeri ringan 3. Nyeri sedang 4. Nyeri berat	Kuesioner <i>Close-Ended</i> dengan skala NRS	Nominal	Skor : 0 = tidak nyeri 1-3 = nyeri ringan 4-6 = nyeri sedang 7-10 = nyeri berat

4.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2025 di Ruang

Operasi RS Prima Husada Sukerejo

4.6 Populasi, Sampel Dan Sampling

4.6.1 Populasi

Populasi dalam penelitian adalah merupakan subjek (misalnya manusia: klien) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. (Nursalam, 2020). Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang menjadi kuantitas dan karakter tertentu yang telah ditentukan

peneliti untuk ditarik kesimpulan. (Donsu, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien post operasi excisi mammae di RS Prima Husada selama bulan Desember 2025

4.6.2 Sampel

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian sebagai sampling. (Nursalam, 2016). Sampel merupakan bagian jumlah dari populasi dan harus memperkirakan ukuran sampel secara logis. (Donsu, 2016). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien post operasi excisi mammae di RS Prima Husada Sukorejo selama bulan Desember 2025 yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

Kriteria inklusinya adalah : 1) dalam kondisi stabil secara hemodinamik (TD, nadi, pernafasan dalam batas normal) ; 2) dapat berkomunikasi dengan baik, mampu memahami instruksi ; 3) bersedia menjadi responden dan menandatangani *informed consent*

Sedangkan kriteria eksklusinya adalah : 1) memiliki riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap lemon, citrus atau essential oil ; 2) memiliki gangguan pernapasan berat seperti asma atau rhinitis alergi berat ; 3) mengalami mual, muntah berat, pusing atau kondisi lain yang dapat diperburuk oleh aroma kuat ; 4) mengalami anosmia atau gangguan penciuman ; 5) mengalami komplikasi pasca operasi seperti perdarahan atau kondisi tidak stabil ;

4.6.3 Sampling

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel. Agar memperoleh sampel yang benar benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. (Nursalam, 2020). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *consecutive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dilakukan dengan cara mengambil seluruh subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan datang secara berurutan dalam kurun waktu tertentu hingga jumlah sampel terpenuhi (Nursalam, 2020).

4.7 Teknik pengumpulan data

4.7.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan proses pengumpulan karakteristik subyek diperlukan yang akan dilakukan pengambilan data penelitian. (Nursalam, 2020).

Proses pada pengambilan data penelitian ini adalah :

- a. Mengurus surat pengantar dari kampus STIKES Husada Jombang untuk pengambilan data
- b. Mengurus perizinan pengambilan data kepada direktur RS Prima Husada Sukerejo
- c. Peneliti melakukan pendekatan dengan calon responden dan meminta persetujuan menjadi responden
- d. Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian
- e. Peneliti menggunakan SOP sebagai acuan pemberian aromatherapy excisi mammae dan kuesioner nyeri menggunakan NRS

f. Peneliti mengolah data dan menyusun laporan hasil penelitian.

4.7.2 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang di alam. (Donsu, 2016).

Instrumen pada penelitian ini adalah SOP dan kuesioner NRS.

4.8 Analisa Data

Analisa data adalah merupakan cara mengelola data agar dapat disimpulkan atau diinterpretasikan menjadi informasi (Donsu, 2017).

4.8.1 *Editing*

Editing adalah upaya memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau yang dikumpulkan (Donsu, 2017). *Editing* pada penelitian ini dilakukan dengan melihat kembali data yang ada apakah ada kesalahan atau kosong sehingga perlu dilakukan perbaikan dan melengkapi data yang kosong.

4.8.2 *Coding*

Coding adalah memberikan identitas pada masing masing angket kuisisioner sesuai nomer untuk responden.

Usia :

17-25 tahun = 1

26-35 tahun = 2

36-45 tahun = 3

>45 tahun = 4

Pendidikan :

Tidak sekolah = 1

SD = 2

SMP = 3

SMA = 4

Perguruan tinggi = 5

Pekerjaan :

Tidak bekerja = 1

Petani = 2

Wiraswasta = 3

PNS = 4

Lainnya = 5

Nyeri :

Tidak nyeri = 0

Nyeri ringan = 1

Nyeri sedang = 2

Nyeri berat = 3

4.8.3 *Scoring*

Untuk mengukur nyeri post operasi excisi mammae menggunakan instrumen dan penyekoran sebagai berikut.

Nyeri :

0 = tidak nyeri

1-3 = nyeri ringan

4-6 = nyeri sedang

7-10 = nyeri berat

4.8.4 *Tabulating*

Tabulating memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam tabel master atau *data base computer*, kemudian membuat distribusi frekuensi atau bias juga dengan menggunakan tabel kontigensi. (Wiratna, 2014).

Menurut (Arikunto, 2014), untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi, digunakan kategori persentase. Setelah kategorinya diketahui kemudian hasilnya di presentase dengan kriteria :

- a. 0% : tidak ada
- b. 1%-25% : sebagian kecil
- c. 26%-49% : hampir setengahnya
- d. 50% : setengahnya
- e. 51%-75% : sebagian besar
- f. 76%-99% : hampir seluruhnya
- g. 100% : seluruhnya

4.8.5 Pengolahan data

Data yang sudah terkumpul di olah dan di identifikasi, kemudian di analisis secara analitik dengan menggunakan uji *wilcoxon* karena untuk menguji analisis pengaruh dua variabel yaitu variabel independen aromatherapy lemon dan variabel dependen nyeri post operasi excisi mammae (Wiratna, 2014).

4.8.6 Pembacaan hasil uji statistika

Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi

excisi mammae di Ruang Operasi Rs Prima Husada Sukorejo menggunakan *uji wilcoxon* dengan perangkat lunak computer program *statistical product and service solution* (SPSS) 16 *for windows* dengan derajat kemaknaan $\alpha = 0,05$. Jika $p < \alpha$ artinya ada pengaruh dua variabel H_0 diterima dan $p > \alpha$ artinya tidak terdapat pengaruh antara dua variabel dan H_0 ditolak.

4.9 Etika penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin kepada direktur RS Prima Husada Sukerejo

4.9.1 Lembar persetujuan menjadi responden (*informed consent*)

Lembar persetujuan diberikan kepada subyek yang akan diteliti, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan riset yang dilakukan serta dampak yang mungkin terjadi selama dan sesudah pengumpulan data. Jika bersedia diteliti, maka harus menandatangani lembar persetujuan tersebut dan bila menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak haknya.

4.9.2 *Anonimity*

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan namanya pada lembar pengumpulan data, cukup dengan memberikan nomor kode masing masing lembar tersebut.

4.9.3 *Confidentiality* (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh subyek dijamin oleh peneliti, penyajian data hasil penelitian hanya ditampilkan dalam forum akademik, lembar persetujuan terlampir

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon, R. (2024). *Psychological support and recovery among post-mastectomy patients*. *Journal of Nursing and Health Psychology*, 16(2), 145–153.
- Attia, H. (2023). *Hormonal regulation, breast tumor pathology, and surgical management*. *International Journal of Gynecology and Endocrinology*, 29(1), 72–81.
- Babbar, K. (2021). *Post-surgical wound care and hygiene practices in breast surgery patients*. *Reproductive and Women's Health Journal*, 19(2), 198–207.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2023). *Laporan kesehatan rumah sakit Jawa Timur tahun 2023*. Surabaya: Dinkes Jatim.
- Hennegan, J. (2021). *Surgical recovery and quality of life among women undergoing breast-conserving surgery*. *The Lancet Oncology*, 22(4), 355–364.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lestari, D. (2023). *Dampak nyeri pasca operasi terhadap kualitas hidup pasien di rumah sakit*. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 15(2), 77–85.
- Nagy, A. (2023). *Surgical excision of breast tumors: Indications, outcomes, and complications*. *BMC Women's Health*, 23(1), 110–118.
- Nguyen, T. (2024). *Rehabilitation and physiotherapy after breast surgery: A multidisciplinary approach*. *International Journal of Adolescent and Women's Health*, 30(3), 250–259.
- Pargar, S. (2025). *Post-operative complications and long-term outcomes in breast tumor excision*. *Journal of Reproductive Medicine and Health*, 32(1), 67–75.
- Putri, A. (2022). *Efektivitas aromaterapi lemon dalam menurunkan nyeri pasca operasi pada pasien bedah mayor*. *Jurnal Keperawatan Medikal Bedah*, 10(1), 45–52.
- Rahman, F. (2023). *Pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap intensitas nyeri pasien post operasi*. *Jurnal Kesehatan Holistik*, 12(3), 101–110.
- Rasquin, L. (2022). *Infections and wound management in breast surgery patients*. *Women's Health Reports*, 3(2), 201–210.

- Siregar, M. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi manajemen nyeri pada pasien post operasi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 26(2), 55–63.
- Thiyagarajan, A. (2022). *Breast surgery and histopathological approaches to tumor excision*. *Journal of Surgical Oncology Research*, 49(3), 421–430.
- World Health Organization. (2021). *Global guidelines for the management of postoperative pain*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). *Comprehensive breast cancer care: Guidelines for treatment and rehabilitation*. Geneva: WHO Press.
- Yanti, D. (2023). *Dampak psikologis post operasi kanker payudara pada pasien perempuan*. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 15(2), 89–96.

LEMBAR PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN

Kepada Yth Calon Responden, saya adalah mahasiswa program studi S1 Keperawatan STIKES Husada Jombang, sedang melaksanakan pembuatan Skripsi dengan judul “Pengaruh pemberian aromatherapy lemon terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi excisi mammae di Ruang Operasi Rs Prima Husada Sukorejo”. Oleh karena itu saya memohon kesediaan waktu bapak/ibu untuk mengisi kuesioner mengenai penelitian ini.

Seluruh data dan informasi yang saya peroleh dijamin kerahasiannya dan hanya disampaikan untuk kepentingan ilmiah tanpa menyebutkan data pribadi bapak/ibu secara langsung.

Demikian saya sampaikan besar harapan bapak/ibu berkenan menjadi responden dalam proses proposal ini. Jika bapak/ibu tidak berkenan, saya terima keputusan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, namun jika bapak/ibu berkenan saya mohon kesediannya untuk menandatangani lembar persetujuan sebagai responden.

Demikian, semoga seluruh niat baik bapak/ibu mendapatkan balasan terbaik dari tuhan, disembuhkan dan dijauhi dari segala penyakit.

Jombang,
Hormat Saya

Peneliti

LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN

Inisial responden :

Saya telah membaca dan memahami lembar permohonan menjadi responden, selanjutnya saya menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jombang,
Responden,

(.....)

**SOP (STANDART OPERASIONAL PROSEDUR)
AROMATHERAPY LEMON**

Judul	SOP Pemberian Aromatherapy Lemon pada Pasien Post Operasi Excisi Mamae
Pengertian	Aromatherapy lemon adalah terapi komplementer nonfarmakologis menggunakan minyak esensial dari buah lemon (<i>Citrus limon</i>) yang diberikan melalui metode inhalasi untuk memberikan efek relaksasi, menurunkan ketegangan otot, dan membantu menurunkan intensitas nyeri pada pasien post operasi.
Tujuan	1. Memberikan efek relaksasi dan ketenangan. 2. Menurunkan tingkat nyeri pasien pasca operasi. 3. Meningkatkan kenyamanan dan kualitas istirahat pasien.
Indikasi	1. Pasien post operasi (terutama <i>excisi mamae</i>) dengan keluhan nyeri ringan hingga sedang. 2. Pasien dalam kondisi sadar dan dapat berpartisipasi dalam terapi inhalasi.
Kontraindikasi	1. Pasien dengan alergi terhadap minyak esensial lemon. 2. Pasien dengan gangguan pernapasan berat (misalnya asma akut).
Persiapan Alat dan Bahan	1. Minyak esensial lemon murni (100% <i>Citrus limon</i>). 2. Diffuser atau kapas steril. 3. Air hangat (jika menggunakan diffuser). 4. Wadah kecil / mangkuk. 5. Tisu / handuk kecil. 6. Masker (untuk petugas). 7. Lembar observasi untuk mencatat respon pasien.
Persiapan Pasien	1. Jelaskan tujuan dan prosedur terapi pada pasien. 2. Pastikan pasien dalam posisi nyaman (duduk atau setengah berbaring). 3. Pastikan area ruangan bersih, tenang, dan memiliki ventilasi baik.
Tahap Kerja / Prosedur Pelaksanaan	1. Cuci tangan dan gunakan APD sesuai standar. 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 3. Teteskan 2–3 tetes minyak esensial lemon ke kapas steril atau diffuser. 4. Letakkan kapas $\pm 20\text{--}30$ cm dari hidung pasien atau aktifkan diffuser selama 10–15 menit. 5. Anjurkan pasien untuk bernapas perlahan dan dalam melalui hidung. 6. Amati respon pasien selama terapi (misalnya tanda relaksasi, ekspresi wajah, atau keluhan nyeri). 7. Catat hasil observasi pada lembar pemantauan (sebelum dan sesudah terapi).

	8. Bersihkan alat setelah digunakan dan cuci tangan kembali.
Evaluasi	1. Observasi perubahan intensitas nyeri pasien (menggunakan skala nyeri, misalnya <i>Numeric Rating Scale</i> 0–10). 2. Catat setiap reaksi alergi atau efek samping yang muncul. 3. Ulangi terapi sesuai kebutuhan dan protokol rumah sakit.
Keamanan dan Keselamatan	1. Pastikan minyak esensial tidak mengenai kulit atau mata pasien. 2. Jangan gunakan di ruangan tertutup tanpa ventilasi. 3. Hindari kontak langsung minyak esensial dengan alat medis atau luka operasi.

KUESIONER NYERI POST OPERASI ECXISI MAMAE

Berilah tanda (✓) pada jawaban anda !

No Responden :

Usia :

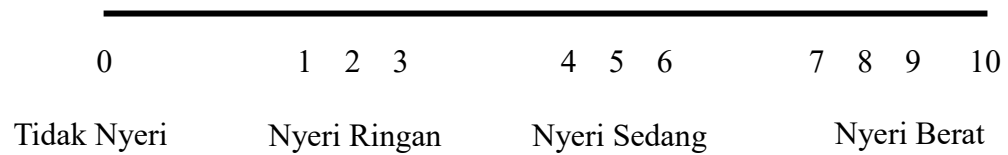
Pendidikan : ☐ Tidak sekolah
☐ SD
☐ SMP
☐ SMA
☐ Perguruan Tinggi

Pekerjaan : ☐ IRT
☐ Petani
☐ Wiraswasta
☐ PNS
☐ Lainnya

Pada skala ini diisi oleh peneliti setelah responden menunjukkan angka berapa nyeri yang dirasakan dengan menggunakan skala nyeri Numerik Rating Scale (0- 10) yaitu :

1. 0 : Tidak nyeri
2. 1-3 : Nyeri ringan (Nyeri masih bisa ditahan, masih dapat melakukan aktivitas)
3. 4-6 : Nyeri sedang (Nyeri mulai menyebar, mulai sulit melakukan aktivitas)
4. 7-10 : Nyeri berat (Nyeri tidak bisa ditahan, tidak bisa melakukan aktivitas)

Tanyakan kepada responden pada angka berapa nyeri yang dirasakannya dengan menunjukkan posisi yang sesuai untuk menggambarkan nyeri yang dirasakan oleh responden dengan membuat tanda (X) pada skala yang telah disediakan



LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :

NIM :

Judul Proposal Skripsi:

Dosen Pembimbing 1 :

[illegible]

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :

NIM :

Judul Proposal Skripsi:

Dosen Pembimbing 2 :

[illegible]